جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : هند محمد على محمود
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** =====
رقم البطاقة : 28409102104324 **رقم التليفون :** 01146025460 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 10-09-1984 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هند محمد على محمود
National ID: 28409102104324

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



هند
محمد على محمود
٤٥ ش سعيد سالم - عزبة دلاور
بولاق الدكرور - الجيزه

٢٨٤٠٩١٠٢١٠٤٣٢٤

LD3670280

٠١١٤٦٠٢٥٤٦٠
٠١٠٤٩٥٩١٩٩

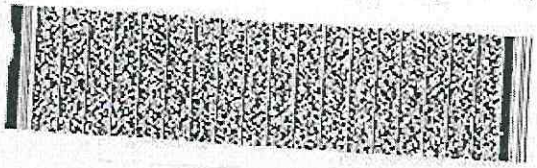
National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

٢٨٤٠٩١٠٢١٠٤٣٤ ٢٠٢٥/٠٥

بدون عمل

أنثى مسلمة أنسة

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٥/٠٧



National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: هند محمد علي محمود **MR. :** 1801	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is currently receiving tamoxifen, calcium supplementation (1 tablet daily), and a single dose of Zoladex 10.8 mg subcutaneously for breast disease management. Imaging studies ordered include a breast ultrasound and a chest X-ray, and a complete laboratory panel has been requested.

Pathology revealed bilateral breast cancer: the right breast (RT) is grade 1, estrogen receptor (ER) positive, progesterone receptor (PR) 6/5, HER2 3+; the left breast (CT2) is grade N2, ER/PR negative (0/8), HER2 negative. The patient completed neoadjuvant chemotherapy consisting of 4 cycles of AC followed by 4 cycles of THP, then underwent bilateral breast-conserving surgery with sentinel lymph node biopsy (SLNB) and left axillary lymph node dissection (ALND) in December 2023, achieving ypT1 ypN0 status. Adjuvant therapy includes KADCYLA, tamoxifen, and Zoladex. The patient has a history of surgically resected oligodendroglioma in 2020; recent brain MRI (June 2026) shows postoperative changes with encephalomalacia and gliosis. Neck ultrasound identified a small hypoechoic thyroid nodule; breast ultrasound demonstrated a left breast oval hypoechoic mass at the 10-o'clock position measuring 10 × 6.5 mm, classified as BIRADS 4A, for which a biopsy is planned today. Additional orders include Zoladex, Zomet, and a single ampoule of CA.

A second-look breast ultrasound performed with Dr. Mona Zaky identified a BIRADS III lesion. The plan is short-term follow-up in three months, with consideration of switching to an aromatase inhibitor at the next multidisciplinary team visit.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد

يعتمد ,

Patient's Name:	**Hind Mohammed Ali**
Date:	**2026-06-30**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

BILATERAL DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH HIGH RESOLUTION BREAST SONOGRAPHY REVEALED:

CLINICAL SUMMARY:
Bilateral CBS

FINDINGS:

LEFT BREAST:
- Dense fibroglandular densities. (ACR c), with focal parenchymal disruption seen, associated with skin and trabeculae thickening.
- No spiculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications
- **Ultrasound demonstrated a circumscribed oval hypoechoic mass at 10 oclock zone b measuring 10 x 6.5 mm, with no abnormal vascularity on colour doppler**
- Clear axilla, and no pathological infra or supra-clavicular lymph nodes.

RIGHT BREAST:
- Dense fibroglandular densities. (ACR c), with focal parenchymal disruption seen, associated with skin and trabeculae thickening.
- No spiculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions, just subtle focal disruption seen underlying the scar site.
- Clear axilla, and no pathological infra or supra-clavicular lymph nodes.

CONCLUSION:
right breast (BIRADS 4A): Post operative changes wih 10 oclock solid lesion as described for biopsy to exclude malignancy
left **breasts (BIRADS 2):** Post-therapeutic sequalae.

Dr farah elshobaky

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]